

QCM Pédiatrie

Variante de 2020:

1. *Un enfant avec sifflement/wheezing récurrent, risque à développer un asthme s'il a:
 - A. Deux critères majeurs et trois critères mineurs
 - B. Deux critères majeurs et un critères mineur
 - C. Un critères majeur et un critère mineur
 - D. Un critères majeur et deux critères mineurs
 - E. Deux critères majeurs et deux critères mineursREP: D

> 4 épisodes + 1 critère majeur et 2 mineurs = risque élevé d'asthme
2. Un nourrisson avec reflux-gastro-oesophagien compliqué avec une oesophagite as:
 - A. Hyperglycémie
 - B. Une diarrhée
 - C. Des vomissements douloureux, parfois
 - D. Des tortillements accompagnés d'érythrose
 - E. Des pleurs, tortillements per prandiaux avec difficulté de finir le biberonREP: CDE
3. L'anémie ferriprive:
 - A. Est une anémie hypochrome --> TCMH < 32%
 - B. Est une anémie normochrome
 - C. Est une anémie microcytaire --> VGM < 80
 - D. Est une anémie macrocytaire
 - E. Est la première cause d'anémie en pédiatrieREP: ACE
4. Les signes d'insulinorésistance sont:
 - A. Hyperglycémie
 - B. Syndrome des ovaires polykystiques
 - C. Acanthosis nigricans
 - D. Hypotension artérielle
 - E. perte de poidsREP: AC(B)

- Perte poids
- Infections, mycose
- Acidocétose
- Acanthosis N.
5. Le diagnostic du rhumatisme articulaire aiguë est établi par:
 - A. Un critère majeur et deux critères mineurs
 - B. Deux critères majeurs
 - C. Trois critères majeurs
 - D. Quatre critères mineurs
 - E. Trois critères mineursREP: AB

+ associé à une preuve d'infection strepto récente

6. Le tableau clinique d'une infection urinaire chez le nourrisson peut présenter:

A?? = enfant

A. Une dysurie

B. Un purpura

C. Une fièvre

D. Une toux

E. Une bradycardie

REP: AC

+ troubles digestifs

+ AEG

+ prise poids insuffisante

+ ictère cholestatique

7. Les signes cliniques d'appel pour une leucémie sont:

A. Toux

B. Fièvre prolongée

C. Un épistaxis

D. Une fièvre prolongée

E. Une pâleur cutanée

REP: BCDE

- Anémie : asthénie, pâleur, dyspnée

- Thrombopénie : ecchymoses, épistaxis, gingivorragies, hématurie, sang selles

- Neutropénie : fièvre prolongée, angine récidivante, aphtose

8. Les affirmations suivantes sur le dosage des anticorps pour le diagnostic de la maladie coeliaque sont fausses:

E??

= vrai

A. Dosage IgA sériques antitransglutaminases (TGA) en 1ère intention, dosage simultané des IgA totales pour éliminer un --> IgA = 1ère intention

B. IgG anti transglutaminases ou IgG anti-endomysium en cas de déficit en IgA --> OUI

C. Dosage IgA sériques anti transglutaminases (TGA) en 1ère intention --> OUI

D. Dosage simultané des IgE --> IgA

E. Test diagnostique essentiel et suffisant en 1ère intention : IgA anti transglutaminases

REP: DE

9. Les manifestations cliniques de la mucoviscidose sont:

A. Oedème hyperprotéique --> HYPOprotéique

B. Arythmies cardiaques

C. Hyperkaliémie --> HYPOkaliémie

D. Iléus méconial

E. Toux chronique

REP: DE

10. Les causes non infectieuses de la myocardite sont:

A. Rarement: champignons, rachitisme, protozoaires et parasites --> infectieuse

B. Le virus de l'épstein Barr, cytomégalovirus, le virus de l'herpès --> infectieuse

C. Maladies collagènes

D. Myocardite primitive Fiedler

E. Allergiques, immuno-allergiques

REP: CDE

Non infectieuse :

- Chimique, toxique, médicamenteux

- Allergie, auto-immun

- Idiopathique : Fielder

11. Le tableau clinique d'une hypothyroïdie acquise associe:

JUSTE E???

- A. Agitation
 - B. Macroglossie avec la sialorrhée
 - C. Tachycardie
 - D. toux
 - E. une peau sèche et les extrémités froides
- HTA
- Vergetures pourpres
- Erythrose faciale
- Peau sèche
- Chute cheveux
- Goitre
- Constipation

REP: BE

12. Les suivantes assertions sur l'infection urinaire (IU) de l'enfant sont vraies:

- A. Se complique avec intolérance au lactose
- B. La maturité vésicale physiologique favorise IU
- C. Escherichia coli (E. coli) est la principale bactérie responsable
- D. Sont plus fréquent chez les garçons --> filles
- E. peut associer des troubles digestifs: diarrhée et/ou vomissements

REP: CE

13. Les dernières affirmations sur la bronchiolite sont fausses:

- A. Est associé à une broncho sécrétion importante --> OUI
- B. Le sifflement/wheezing évoque une bronchiolite --> OUI
- C. L'agent étiologique commun est streptococcus pneumoniae --> VRS
- D. Bronchiolite est caractérisée par une inflammation de la paroi bronchiolaire --> OUI
- E. une restriction pulmonaire s'associe

REP: CE

14. Le tableau clinique de la tétralogie Fallot comprend:

- A. Des crises hypoxiques
 - B. une cyanose profonde et position du squatting (accroupissement)
 - C. Une tachycardie
 - D. Des doigts hippocratiques
 - E. Une hyperpyrexie
- + dyspnée
+ tachypnée

REP: ABD

15. La tétralogie de Fallot est représentée par l'absence des lésions suivantes:

- A. Le défaut septal interventriculaire péri-membraneux --> OUI
- B. l'hypertrophie ventriculaire droite --> OUI
- C. Le défaut septal interatrial péri-membraneux --> inter-VENTRICULAIRE
- D. la sténose infundibulaire de l'aorte --> de l'artère PULMONAIRE
- E. La sténose infundibulaire de l'artère pulmonaire --> OUI

REP: CD

Fallot :

- Le défaut septal interventriculaire péri-membraneux
- La dextroposition de l'aorte
- La sténose infundibulaire de l'artère pulmonaire
- L'hypertrophie ventriculaire droite

Variantes:

- La tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire
- La tétralogie de Fallot avec valve pulmonaire absente

16. La dystrophie de premier degré "malnutrition sous clinique" ou le nanisme nutritionnel:

???

- A. Tissus adipeux sous-cutanés est diminué sur le thorax et l'abdomen, le pli cutané abdominal < 1.5
 - B. L'activité motrice est normale ou légèrement inférieure
 - C. indice pondérale= 0,89-0,76 il y a un déficit pondéral de 10-20% par rapport au poids idéal, bien que la taille est normale
 - D. Courbe de poids est bien diminué
 - E. Les téguments sont pâles, la musculature est hypotonique
- REP: ABC

17. Des causes des diarrhées chroniques sont:

- A. L'allergie aux protéines de lait de vache
 - B. l'infection à salmonelle
 - C. La mucoviscidose
 - D. Le syndrome Ehler Danlos
 - E. L'infestation avec Echinococcus granulosus
- REP: AC

18. le tableau clinique du diabète type I:

- A. La polyurie
 - B. Une anurie
 - C. La polydipsie
 - D. Un refus alimentaire
 - E. Une énurésie
- REP: ACE

19. Pour le rachitisme de l'enfant, les suivantes affirmations sont fausses:

- A. La zone sous périostée des diaphyses est minéralisée --> faux
 - B. Vitamine D inhibe l'excrétion urinaire du Ca^{2+}
 - C. Se manifeste avec pâleur, nervosité, sommeil agité
 - D. Associe un retard du développement staturo-pondéral --> OUI
 - E. Parathormone inhibe l'absorption intestinale du Ca^{2+}
- REP: AC

20. Les critères du "American college de Rheumatology" pour le diagnostic de lupus érythémateux systémique de l'enfant sont:

D??

- | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| A. Anticorps | - Eruption ailes papillon | - Encéphalopathie |
| B. Rash malaire --> ailes papillon | - Atteinte cellules sanguines | - Photosensibilité |
| C. Photosensibilité | - Anomalies immunologiques | - Lupus discoïde |
| D. Leucopénie <4000/mm ³ x 2 fois | - Arthrite non érosive | - Ulcération muqueuse |
| > 0,5 g/j --> E. Protéinurie >0,1 g/24h | - Epanchement pleural/péricardique | - Néphropathie |
| REP: ABCD | - Présence facteurs antinucléaires | |

21. Le syndrome Pickwick est caractérisé par:

- A. Hématologique: polyglobulie
- B. Insuffisance respiratoire chronique, dyspnée, cyanose, coeur pulmonaire chronique
- C. Obésité monstrueuse, principalement abdominale
- D. Insuffisance respiratoire aiguë, dyspnée, cyanose, coeur pulmonaire aiguë
- E. Obésité monstrueuse, principalement tronculaire

REP: ABE

22. Les critères immunologiques nécessaires pour le diagnostic du lupus érythémateux systémique sont:

- A. Ac ANA > valeurs des références
- B. Une anémie hémolytique
- C. Les fractions de compléments réduit: C3, C4, CH50
- D. Thrombocytémie < 100 000/mm³
- E. Des ulcérations muqueuses

REP: AC

23. Les affirmations suivantes sur l'angine à streptocoque groupe A (SGA) sont vraies:

- A. Les adénopathies sont absentes
- B. test de diagnostic rapide peut détecter SGA
- C. La dysphagie est importante
- D. Peut associer absence de rhinorrhée, de toux ou de dysphonie
- E. Sont plus fréquent chez les garçons

REP: BCD

24. Les suivantes affirmations sur la protéinurie d'origine glomérulaire sont fausses:

- A. La protéinurie non sélective lorsqu'elle comporte aussi des protéines plasmatiques de masse moléculaire supérieur à celle de l'albumine, une néphropathie avec des lésions plus sévères
- B. Sélective lorsqu'elle ne comporte que des protéines plasmatiques de masse moléculaire inférieure ou égale à celle de l'albumine, une néphropathie sans lésions décelables en microscopie optique
- C. C'est une protéinurie composée essentiellement d'albumine
- D. La protéinurie sélective lorsqu'elle comporte aussi des protéines plasmatiques de masse moléculaire supérieure à celle de l'albumine, une néphropathie avec des lésions plus sévères
- E. C'est une protéinurie composée de protéines de masse moléculaire inférieure à celle de l'albumine (alpha-2-microglobulinémie)

REP: DE

25. La néphropathie diabétique de l'enfant a les suivantes caractéristiques biologiques:

- A. La diminution ou la disparition de la glycémie
- B. Hypercalcémie
- C. Hypoazotémie
- D. Hypoalbuminémie (43%), hyper alpha 2 (>15%)
- E. Protéinurie et hématurie

REP: DE

26. Les suivantes sont des causes de convulsions fébriles chez le nourrisson, sauf:

- A. Dyselectrolitémie
- B. Tumeur cérébrale
- C. Infection neuroméningée
- D. Abscès cérébral
- E. Thrombophlébite

Crise fébrile, infection neuroméningée, abcès cérébral, thrombophlébite cérébrale, SHU, neuropaludisme

REP: AB

27. Les affirmations suivantes sur pneumonies bactériennes de l'enfant sont vraies:

- A. Les cultures des crachats et nasopharyngé révèle l'étiologie
- B. les pneumonies compliquées sont traitées pour 3-6 semaines
- C. Sont caractérisée par des opacités parenchymateuses à la
- D. L'étape d'hépatisation grise est spécifique pour les premiers 1-2 jours
- E. Les agents étiologiques majeurs sont Aspergillus et chlamydia trachomatis

REP: ABC

28. Les critères d'admissions d'un enfant avec bronchiolite sont:

- A. La saturation en oxygène > 98%
- B. Le manque de possibilité d'une surveillance correcte
- C. Moins de 3 mois d'âge
- D. Comorbidités associées
- E. Wheezing(sifflement) audible sans stéthoscope

REP: BCD

29. Les convulsions partielles simples sont:

- A. Permanentes
- B. Décharges électriques paroxystiques des neurones corticales
- C. Avec des manifestations motrices localisées
- D. Associe des symptômes respiratoires
- E. Sans l'affection de l'état de conscience

REP: BCE

30. La période répliquative de l'hépatite chronique avec virus B, est caractérisé par la présence des:

- A. Ag HBe positif
- B. Ag HBs positif
- C. Ac anti-HBs positives (=>anticorps dus au vaccin)
- D. Anticorps anti-HBe positives (=>porteur inactif)
- E. ADN viral PCR positif

REP: ABE

31. Le diagnostic différentiel des convulsions se fait avec:

- A. Myoclonies du sommeil
- B. Spasmes du sanglot
- C. Frissons
- D. toux chronique
- E. Syncopes vagales convulsivantes

REP: ABCE

32. Quels sont les éléments spécifiques pour la forme systémique de l'arthrite rhumatoïde juvénile:

- A. Une céphalée
- B. une absence de douleurs articulaires
- C. Une hépatomégalie
- D. Une fièvre d'au moins 2 semaines
- E. une éruption érythémateuse transitoire

REP: ADE

33. la maladie de kawasaki est caractérisée par les altérations biologiques:

- A. Une méningite lymphocytaire aseptique
- B. élévation de la vitesse de sédimentation
- C. Leucopénie au liquide synovial
- D. une augmentation des transaminases et GGT
- E. Hyperalbuminémie --> HYPO

REP: ABD

34. Le syndrome néphrotique (SN) est défini par:

- A. Une perte de poids
- B. des oedèmes des jambes
- C. Hypoprotidémie < 60 g/L avec Hypoalbuminémie < 30g/L
- D. hypotension artérielle
- E. Protéinurie > 50 mg/kg par 24h

REP: CE

35. L'hémogramme (NFS-Plaquettes) d'une leucémie aiguë lymphoblastique peut présenter:

- A. Une monocytose
- B. une polyglobulie
- C. Une pancytopénie sans blastes
- D. une hypo éosinophilie
- E. Une hyperleucocytose avec blastose sanguine

REP: CE

36. Les principes de l'antibiothérapie des exacerbations respiratoires de la mucoviscidose sont:

- A. Soins prolongés de 3-4 mois, durant les périodes d'exacerbation
- B. Doses administrés plus faible que d'autres maladies
- C. Aérosols combinée avec antibiotique
- D. Le traitement est adapté en fonction de la gravité des symptômes
- E. Le traitement n'est pas adapté en fonction de la gravité des symptômes

REP: CD

???

37. Dans la D-transposition classique de gros vaisseaux: = inversion des gros vaisseaux

- A. L'artère pulmonaire émerge du ventricule gauche
- B. La cyanose est grave dès la naissance
- C. l'aorte émerge du ventricule gauche --> du VD
- D. L'aorte émerge du ventricule droit
- E. Il ne faut pas exister un mélange du sang

REP: ABD

38. Les affirmations suivantes sur l'épiglottite sont vraies:

- A. Des signes cliniques sont dyspnée inspiratoire marquée, stridor
- B. L'étiologie comprend haemophilus influenzae et le pneumocoque
- C. A une évolution suraiguë
- D. A une évolution chronique
- E. C'est la forme la plus grave de laryngite

REP: ABCE

39. Les annonces suivantes sur la GN aiguë post streptococcique sont vraies:

- A. Les oedèmes n'existe pas
- B. La fraction C3 du complément est abaissé
- C. La protéinurie est de type néphrétique (<50 mg/kg/jr ou 40 mg/m2/h)
- D. Est une maladie des complexes immuns circulants
- E. Apparition possible après infections à streptocoque bêta-hémolytique de groupe A

REP: BCDE

Variante E

1. L'angine avec streptocoque du groupe A (SGA) s'associe avec:
 - A. Leucopénie ou leucocytose avec lymphocytose --> virale
 - B. leucocytose avec neutrophilie
 - C. Leucopénie ou leucocytose sont évocateurs d'angine bactérienne --> virale
 - D. Indices d'inflammation (protéine C réactive, fibrinogène) augmentées
 - E. VSH diminué --> augmentéREP: BD
2. Les manifestations cliniques typiques pour la mucoviscidose sont:
 - A. Toux sèche
 - B. Diarrhée chronique avec stéatorrhée
 - C. Iléus méconial
 - D. Ictère prolongée
 - E. ObésitéREP: BCD
3. L'angine virale ne peut être caractérisé par:
 - A. Fièvre oscillante, l'anorexie, la dysphagie
 - B. Rhinorrhée, toux sèche
 - C. Leucocytose
 - D. Neutrophilie
 - E. Microvésicules des piliersREP: CD
4. Les dernières affirmations sur l'épiglottite sont vraies:
 - A. L'étiologie est haemophilus influenzae, pneumocoque
 - B. C'est la plus facile forme de laryngite
 - C. A une évolution suraiguë
 - D. Signes cliniques sont dyspnée inspiratoire marquée, stridor
 - E. A une évolution chroniqueREP: ACD
5. Le traitement des laryngites implique:
 - A. Bêta2 mimétique sélective nébulise
 - B. Humidification de l'atmosphère
 - C. Corticothérapie parentérale
 - D. Trachéotomie
 - E. antibiothérapie obligatoireREP: BC

6. Les dernières affirmations sur la bronchiolite sont fausses:
- A. Une restriction pulmonaire s'associe
 - B. bronchiolite est caractérisée par une inflammation de la paroi bronchiolaire
 - C. L'agent étiologique commun est *haemophilus influenzae*
 - D. associé une broncho sécrétion importante
 - E. Le wheezing évoque une bronchiolite
- REP: AC
7. La mucoviscidose est soupçonnée dans la présence de:
- A. La respiration sifflante récurrente
 - B. Prolapsus rectal récidivant
 - C. diabète
 - D. Goût doux de la sueur
 - E. hypertension portale
- REP: ABCE
8. Critères d'admission d'un enfant avec bronchiolite sont :
- A. Moins de 3 mois d'âge
 - B. Wheezing audible sans stéthoscope --> pas critère
 - C. Le manque de possibilité d'une surveillance correcte
 - D. Comorbidités associées
 - E. La saturation en oxygène > 98% --> < 95%
- REP: ACD
9. Le diagnostic différentiel du wheezing s'effectue avec:
- A. Reflux gastro-oesophagien
 - B. Laryngite chronique
 - C. Malformation diaphragmatique
 - D. Compressions extrinsèque (anneau vasculaire, tumeurs)
 - E. Mucoviscidose
- REP: ADE
10. Examens complémentaires dans les pneumonies peuvent révéler:
- A. Leucocytose avec neutrophilie dans les pneumonies virales
 - B. Leucocytose dans les pneumonies bactériennes
 - C. Leucopénie avec lymphocytose-pneumonies virales
 - D. Leucopénie dans les pneumonie virales
 - E. dyslipidémie
- REP: BCD
11. Le contrôle de l'asthme existe s'il y a:
- A. Plus de 3 crises/semaine
 - B. Moins de 2 crises/semaine
 - C. Sans limitation de l'activité
 - D. Besoin du traitement: moins de 2 fois/semaine
 - E. Besoin du traitement: moins de 2 fois/jour
- REP: BCD

12. Le traitement médicamenteux de fond de l'asthme consiste en:

- A. Inhalation journalière de bêta-1 agoniste
- B. Oxygénothérapie pour maintenant Sat O₂ ≥ 95%
- C. Physiothérapie thoracique
- D. corticostéroïdes inhalateurs
- E. Les bronchodilatateurs à longue durée d'action

REP: DE

13. Le syndrome Marfan est caractérisée par:

- A. Déficit staturale
- B. Grande taille
- C. L'hyperlaxité ligamentaire
- D. L'agitation psychomotrice
- E. Respiration sifflante

REP: BC

14. les causes de convulsions afebrile chez le nourrisson et le jeune enfant sont:

- A. L'épilepsie
- B. troubles hydro électrolytique (natrémie, calcémie)
- C. frisson fébrile
- D. Abscès cérébral
- E. Thrombophlébite cérébrale

--> fébrile

REP: AB

15. Les suivantes sont de causes de convulsions fébriles chez le nourrisson sauf:

- A. Dyselectrolitémie
- B. Infection neuroméningée
- C. Abscès cérébral
- D. Tumeur cérébrale
- E. Thrombophlébite cérébrale

REP: AD

16. L'anémie macrocytaire est associé avec:

- A. Thalassémie
- B. carence en vitamine B12
- C. Carence de l'acide folique
- D. L'hyperthyroïdie
- E. Fièvre

REP: BC

17. L'anémie ferriprive:

- A. Est la première cause d'anémie en pédiatrie
- B. Est une anémie macrocytaire
- C. Est une anémie microcytaire
- D. Est une anémie hypochrome
- E. Est une anémie normochrome

REP: ACD

18. Les signes suivants peuvent suggérer une leucémie aiguë lymphoblastique:

- A. Pâleur
- B. Hypothermie
- C. Hématurie
- D. Angine récidivante
- E. Hyperglycémie

REP: ACD

19. Le diagnostic du neuroblastome se fait par:

- A. La radiographie cérébrale
- B. le dosage des catécholamines urinaires --> dopamine et dérivés : VMA + HVA
- C. L'échographie pulmonaire
- D. L'analyse histologique d'un fragment tumoral
- E. Immunogramme

REP: BD

20. *Les malformations cardiaques congénitales prédisposent à l'endocardite à l'exception de:

- A. Tétralogie de fallot
- B. Communication inter auriculaire ostium secundum
- C. Communication inter ventriculaires
- D. Insuffisance mitrale
- E. Cardiomyopathie hypertrophique obstructive

REP: B

21. Le diagnostic positif de l'endocardite se base sur:

- A. Existence obligatoire d'une malformation cardiaque congénitales
- B. présence d'un souffle systolique ou l'apparition de nouveaux souffles
- C. Hémocultures positives
- D. Evidence des végétations à l'échographie
- E. CT scan cérébral

REP:BCD

22. la myocardite s'associe avec:

- A. Bruits cardiaques étouffés, souffle systolique
- B. Wheezing
- C. Hypovoltage du complexe QRS
- D. le coeur en "flash" avec d'angles obtus par rapport au diaphragme
- E. Silhouette cardiaque allongée

REP:ACDE

23. *Les causes des péricardites sont les suivantes, sauf:

- A. Les maladies du collagène
- B. Le traumatisme sternal
- C. La radiothérapie
- D. Les infections avec S. pneumoniae
- E. Tuberculose

REP: B

24. Persistance du canal artériel est associé avec:

- A. Shunt droite à gauche
- B. Shunt de gauche à droite
- C. Cyanose
- D. Souffle holosystolique
- E. Diabète

REP: BD

25. Dans la D-transposition classique de gros vaisseaux:

- A. L'aorte émerge du ventricule gauche
- B. l'artère pulmonaire émerge du ventricule gauche
- C. L'aorte émerge du ventricule droit
- D. Il ne faut pas exister un mélange du sang
- E. La cyanose est grave dès la naissance

REP: BCE

26. Le traitement curatif de l'endocardite utilise les médicaments suivants:

- A. Amoxicilline 50 mg/kg (max 3g) par voie orale
- B. Pénicillines ou l'oxacilline, plus la gentamicine injectable
- C. Vancomycine 40 mg/kg/jour, max 2 g/kg en 4 doses
- D. Erythromycine 20 mg/kg par voie orale
- E. Clindamycine 10 mg/kg (max adulte 300 mg) par voie orale

REP: BC

27. Le tableau clinique de la tétralogie Fallot comprend:

- A. La cyanose profonde et position du squatting (accourpissement)
- B. tachycardie
- C. crises hypoxiques
- D. Hyperpyrexie
- E. Doigts hippocratiques

REP: ACE

28. L'étiologie des vomissements aigus comprend:

- A. Les infection ORL
- B. Hypovitaminose A
- C. Méningite
- D. Infections respiratoires
- E. Syndrome de Down

REP: ACD

29. Le reflux gastro-oesophagien pathologique:

- A. Début généralement précoce dès les premiers jours de vie
- B. Se caractérise par des régurgitations
- C. Est défini comme le passage volontaire du contenu gastrique
- D. Représente la première cause de vomissement chez le nourrisson
- E. associe obligatoirement la diarrhée

REP: ABD

30. les manifestation extra-digestives du reflux gastro-oesophagienne sont:

- A. Toux à prédominance nocturne
- B. Laryngites récurrentes
- C. Protéinurie
- D. Convulsions
- E. Fièvre

REP: AB

31. Les affirmations suivantes sur l'infection par Helicobacter pylori sont vraies:

- A. Est l'une des infections les plus rares dans le monde entier
- B. Helicobacter Pylori est une bactérie gram négatif
- C. Provoque l'ulcère gastro-duodénal
- D. La transmission est aérienne
- E. la gastrite antrale à H. pilori est diagnostiqué par des lésions nodulaires typiques

REP: BCE

32. les régimes thérapeutiques de première ligne dans l'infection avec helicobacter pylori sont:

- A. Amoxicilline (50 mg/kg/jour) + Clarithromycine (15 mg/kg/jour) + IPP, 2 doses/jr
- B. Amoxicilline (50 mg/kg/jour) + Métronidazole (30-40 mg/kg/jour) + IPP, 2 doses/jr
- C. Amoxicilline (100 mg/kg/jour) + Métronidazole (50 mg/kg/jour) + sels de bismuth 2 doses/jr
- D. IPP + Amoxicilline (50 mg/kg/jr) 5 jours
- E. IPP + Clarithromycine (15 mg/kg/jour)

REP: AB

33. les complications possibles de l'infection à hélicobacter pylori sont:

- A. La gastrite chronique
- B. La gastrite aiguë
- C. La métaplasie intestinale
- D. La glomérulonéphrite
- E. L'apparition d'un carcinome gastrique

REP: ACE

34. Les affirmations suivantes sur la diarrhée aiguë sont incorrectes:

- A. Diarrhée aiguë est une affection fréquente
- B. La déshydratation aiguë est la principale complication
- C. causes les plus fréquentes de diarrhée sont bactériennes
- D. Le traitement repose sur la réhydratation par voie orale et la réalimentation précoce doivent être parfaitement expliquées aux parents
- E. les douleurs abdominales sont vraiment rares associés avec diarrhée

REP: CE

35. Signes cliniques de déshydratation intracellulaire sont:

- A. Fontanelle déprimée
- B. Pli cutané persistant --> extracellulaire
- C. temps de recoloration cutané allongé
- D. Hypotonie des globes oculaires
- E. Fièvre

+ soif
+ sécheresse muqueuses
+ troubles conscience

REP: DE

36. Les antibiotiques recommandés, en fonction de l'étiologie, pour les diarrhées aiguës sont:

- A. Shigelle : ampicilline (100 mg/kg/j)
- B. Salmonella : Ceftriaxone (50 mg/kg/j)
- C. Shigella : ibuprofène (20-30 mg/kg/j)
- D. Campylobacter jejuni : Erythromycine (50 mg/kg/j per os)
- E. Salmonelle : Gentamicine 40 mg/kg/j

REP: ABD

37. Les causes de diarrhée chronique énumèrent:

- A. L'allergie aux protéines de lait de vache
- B. Mucoviscidose
- C. Syndrome Marfan
- D. Infection à salmonelle
- E. Infestation avec Echinococcus granulosus

REP: AB

38. la maladie Coeliaque :

- A. Est une entéropathie IgE médiée
- B. Est une entéropathie médiée par le système immunitaire
- C. Survient chez les patients ayant un déficit sélectif en IgA
- D. Survient chez les personnes génétiquement prédisposées (DQ2 ou DQ8)
- E. A des symptômes respiratoires

REP: BCD

39. Les anticorps utilisée pour le diagnostic de la maladie coeliaque énumère:

- A. IgA anti transglutaminases (TGA)
- B. IgM anti transglutaminases
- C. IgG anti-endomysium en cas de déficit en IgA
- D. IgM anti gliadine
- E. les anticorps anti-peptides de la gliadine désaminée

REP: ACE

40. les protéines qui causent l'allergie sont:

- A. Beta-lactoglobuline
- B. gamma-lactoglobuline
- C. Caséine
- D. Albumine
- E. Immunoglobuline G

REP: AC

41. L'hépatite chronique avec virus B, dans la période inactive non répliquative est caractérisée par la présence des:

- A. Ag HBs
 - B. Ac anti-HBs
 - C. Ag HBe
 - D. ADN viral PCR
 - E. Ac anti-Hbe
- REP: AE

42. L'hépatite C chronique a les suivantes caractéristiques sérologiques positives:

- A. Ac IgM anti-VHC
 - B. Ac IgG anti-VHC
 - C. IgM-HBc
 - D. IgG- anti HBc
 - E. ARN viral par PCR
- REP: BE

43. Les porteurs VHB ont :

- A. Ag HBs positif
 - B. Ac IgM anti-HBc positifs
 - C. Ac IgM anti-HBc négatifs
 - D. Ac IgM anti-delta positifs
 - E. Ac IgG anti-VHD positifs
- REP: AD

???

GPT : ACE

44. Les manifestations cliniques de la giardiase sont:

- A. Un appétit vorace --> capricieux
 - B. Les douleurs épigastriques --> nombril, hypochondre DR
 - C. Halitose sulfureuse le matin
 - D. la perte de poids --> par malabsorption
 - E. L'urticaire --> prurit
- REP: CDE

45. Les déclarations suivantes sont vraies à propos de GNA post streptococcique

- A. L'étiologie sont des souches particulières (nephritigène) de streptocoques bêta hémolytique de groupe A
 - B. La culture d'urine relève leucocyturie, cylindrurie, bactériurie
 - C. l'entrée respiratoire ou cutanée
 - D. maladie "des complexes immuns circulants"
 - E. les oedèmes se produisent pendant l'angine streptococcique
- REP: ACD

46. Le syndrome urinaire dans GNA post streptococcique est caractérisé par:

- A. oligurie
- B. hématurie
- C. protéinurie modéré
- D. densité urinaire réduit
- E. protéinurie sélective au début

REP: ABC

47. le tableaux clinique de l'infection urinaire chez le nourrisson et petit enfant:

- A. Fièvre
- B. Ictère
- C. Vomissements, diarrhée
- D. Urine nuageux (pyurie)
- E. purpura

REP: ABC(D)

48. Le syndrome néphrotique (SN) se caractérise par:

- A. Protéinurie massif sélectif
- B. oedème généralisées massif
- C. Hypoprotéinémie
- D. Dysprotéinémie
- E. Hyperalbuminémie

REP: ABC

49. Les manifestations majeures du RAA (rhumatisme articulaire aigu) sont les suivant:

- A. Polyarthrite aiguë fugace et mobile
- B. Cardite
- C. Céphalée
- D. Nodules sous cutanés
- E. érythème facial

REP: ABD

50. Le traitement du syndrome néphrotique (SN) par thérapie immunosuppresseur est indiqué en cas de:

- A. SN stéroïdes sensible avec rechutes souvent
- B. SN stéroïdes sensible avec évènement V d'intolérance à corticostéroïdes
- C. Formes de SN secondaire, sensible aux stéroïdes
- D. Formes de SN congénital et familial
- E. Formes de SN stéroïdes-sensible ou sans stéroïdes-intolérance

REP: AB

Variante A

1. L'angine virale ne peut être caractérisé par:
 - A. Fièvre oscillante, l'anorexie, la dysphagie
 - B. Rhinorrhée, toux sèche
 - C. Leucocytose
 - D. Neutrophilie
 - E. Microvésicules des piliersREP: CD
2. L'asthme est contrôlé quand l'enfant a:
 - A. Plus de 3 crises/semaine
 - B. Moins de 2 crises/semaine
 - C. Sans limitation de l'activité
 - D. Besoin du traitement: moins de 2 fois/semaine
 - E. Besoin du traitement: moins de 2 fois/jourREP: BCD
3. complications métaboliques de l'obésité de l'enfant sont:
 - A. Diminution de la tolérance au glucose, la glycémie pendant TTGO < 126 mg% à 0 min et < 200 mg% à 120 min
 - B. Diminution de la tolérance au glucose, la glycémie pendant TTGO > 126 mg% à 0 min
 - C. les altérations du métabolisme protéique : hypoprotéinémie, hyperuricémie
 - D. les altérations du métabolisme protéique : dysprotéinémie, hyperuricémie
 - E. les altérations du métabolisme lipidique : dyslipidémie, hyperlipidémieREP: ADE
4. Le syndrome pickwick est caractérisé par:
 - A. Obésité monstrueuse, principalement abdominale
 - B. obésité monstrueuse, principalement tronculaire
 - C. insuffisance respiratoire chronique, dyspnée, cyanose, coeur pulmonaire chronique
 - D. insuffisance respiratoire aiguë, dyspnée, cyanose, coeur pulmonaire aigu
 - E. hématologique : polyglobulieREP: BCE
5. Dystrophie II degré est caractérisé par :
 - A. Indice nutritionnel = 0,6-à 0,71
 - B. L'activité motrice est normale ou légèrement inférieure
 - C. diminution du métabolisme basal explique la tendance à l'hypothermie et une insuffisance circulatoire
 - D. il est l'état le plus grave du trouble chronique nutritionnel
 - E. courbes de poids est à la baisse dans des étapesREP: ACE

6. Les affirmations suivantes sur les objectifs thérapeutiques en CAD sont vraies:
- A. correction de l'acidose métabolique par un apport hydrique adapté, insulinothérapie = administration du NaHCO_3
 - B. la glycosurie et la cétonurie doivent être surveillé une fois à 8h
 - C. la glycosurie et la cétonurie doivent être surveillé une fois au 3-4 H au moins
 - D. la dose d'insuline se baisse seulement après l'acidose a été corrigé
 - E. la dose d'insuline se baisse seulement depuis que l'acidose a été corrigé
- REP: ACD
7. L'insuline à l'action intermédiaire:
- A. actionné après 15-30 minutes
 - B. l'activité commence dans 2-3 h après injection
 - C. a un pic maximal d'action de 3-8 H
 - D. durée d'action 12-18 heures
 - E. une durée d'action maximale 7-15 Heures
- REP: CD
8. Les nodules d'ASCHOFF:
- A. Peuvent être retrouvées au niveau des poumons, du foie, des reins et au niveau de l'encéphale --> OUI
 - B. siègent sous l'endocarde
 - C. Ils comportent schématiquement deux zones : une zone centrale hyaline et une zone périphérique avec des cellules épithélioïdes
 - D. ont une zone périphérique avec une couronne de lymphocytes, de monocytes et de polynucléaires
 - E. Ont une zone moyenne avec des cellules épithélioïdes
- REP: BDE
9. La chorée de SYDENHAM:
- A. Ne laissent jamais de séquelles neurologiques
 - B. ce sont des mouvements involontaires, rapides de grande amplitude
 - C. l'hypotonie, l'ataxie et les mouvements choréiques disparaissent lentement
 - D. l'hypotonie, l'ataxie et les mouvements choréiques disparaissent rapidement
 - E. C'est une manifestation du début de la maladie streptococcique
- REP: ABC
10. Traitement du purpura rhumatoïde de l'enfant henoch-schonlein est:
- A. Pénicillinothérapie au long cours, benzathine pénicilline en injection intramusculaire toutes les trois semaines pendant 5 ans en l'absence de cardite et le plus longtemps possible si une cardite est associée
 - B. Amygdalectomie traitement ou avulsion des dents mortifiés
 - C. absence de traitement spécifique
 - D. dans les formes digestives sévères: corticothérapie et nutrition parentérale
 - E. dans les formes rénales, en fonction des résultats de la biopsie rénale, discussion entre l'abstention thérapeutique, la corticothérapie et les immunosuppresseurs
- REP: CDE

11. evolution de la maladie de Kawasaki

- A. la phase aiguë(J0-J10) : atteinte cardiaque rare
 - B. la phase aiguë (J0-J10) : constatation d'anévrismes et de sténose cicatricielles en cas de complications coronaire à la deuxième phase
 - C. la phase subaiguë (J10-J20) : diagnostic de complication coronaire
 - D. la phase subaiguë (J10-J20) : atteinte cardiaque rare
 - E. La phase de convalescence (J20-J70) : constatation d'un anévrisme et de sténose cicatricielles en cas de complication coronaire à la deuxième phase
- REP: ACE

12. AJI forme oligo-articulaire

- A. la classification ILAR distingue 2 sous groupes : une forme oligo articulaire persistante et une forme extensive ou l'atteinte peut devenir polyarticulaire avec l'évolution --> OUI
 - B. est définie par l'atteinte de cinq articulations
 - C. est définie par l'atteinte de quatre articulations ou moins pendant les 6 premiers mois d'évolution de la maladie
 - D. prédominant chez les garçons et sans associé à la présence de FAN et un risque réduit d'iridocyclite
 - E. prédominant chez les filles et s'associant à la présence de FAN et un risque élevé d'iridocyclite
- REP : CE

F.

13. Les manifestations cliniques typiques pour la mucoviscidose sont:

- A. toux sèche
 - B. diarrhée chronique avec stéatorrhée
 - C. iléus méconial
 - D. ictère prolongée
 - E. obésité
- REP: BCD

14. les causes de convulsions afebriles chez le nourrisson et le jeune enfant sont:

- A. épilepsie
 - B. troubles hydroélectrolytiques (natrémie, calcémie)
 - C. frisson fébrile
 - D. abcès cérébral
 - E. thrombophlébite cérébrale
- REP: AB

15. *Diagnostic de RAA:

- A. 2 critères majeurs sans associés à une preuve d'infection streptococcique récente
 - B. 2 critères mineurs
 - C. 2 critères majeurs ou un critère majeur et 2 critères mineurs associés à une preuve d'infection streptococcique récente
 - D. seulement 2 critères mineurs associés à une preuve d'infection streptococcique récente
 - E. 1 critère majeur sans associé une preuve d'infection streptococcique récente
- REP: C

16. Le syndrome néphrotique (SN) est défini par:

- A. Une protéinurie < 50 mg/kg/24h
- B. Une protéinurie > 50 mg/kg/24h
- C. Hypoprotidémie > 60 g/L
- D. Hypoprotidémie < 60 g/L
- E. Hypoalbuminémie < 30 g/L

REP: BDE

17. Les indications de la PBR sont:

- A. Corticosensibilité (rémission complète)
- B. SN pur persistant
- C. SN impur persistant
- D. Début avant l'âge de 1 an ou après l'âge de 11 ans
- E. Début depuis l'âge de 1 an ou avant l'âge de 11 ans

REP: CD

18. Le recours à un traitement antithrombotique préventif est indiqué dans les situations à risque:

- A. Forme clinique sévère (anasarque)
- B. fibrinogène <6 g/L
- C. albuminémie <20 g/l
- D. antithrombine III >70%
- E. d-dimères <1000 ng/ml

REP: AC

19. Les signes de gravité dans les infections urinaires sont:

- A. Nourrisson de moins de 3 mois d'âge
- B. Uropathie sous-jacente
- C. Pyonéphrose: reins volumineux et douloureux à la palpation de fosses lombaires
- D. abcès rénal: reins douloureux spontanément
- E. Immunodépression --> critère, pas signe

REP: CDE

20. les signes orientant vers une cause potentiellement grave évoquant une cause centrale de l'anémie sont:

- A. syndrome hémorragique grave avec purpura
- B. ictère conjonctival
- C. fièvre, angine, stomatite
- D. urines rouges ou foncées
- E. syndrome tumoral : adénopathies, hépatosplénomégalie

REP: AE

21. Ne sont pas classés comme une anémie macrocytaire:

- A. Thalassémie alpha ou bêta
 - B. anémie des maladies chroniques
 - C. anémies par carence en fer
 - D. anémie mégaloblastique osseuse (hypothyroïdie, hépatopathie, alcoolisme, le méthotrexate, zidovudine)
 - E. l'anémie par carence en vitamine B12 ou de l'acide folique
- REP: ABC

22. La carence en vitamine B12 est secondaire aux causes suivantes:

D??

- A. l'apport des anti épileptiques
 - B. malnutrition souvent
 - C. pathologie du grêle distal (résection, maladie de Crohn)
 - D. pathologie du grêle proximal (résection, maladie coeliaque)
 - E. apport de colchicine
- REP:BC

23. Les manifestations d'insuffisance médullaire associée à thrombopénie sont :

- A. purpura pétéchiale
 - B. ecchymoses diffuses ou dans des sites inhabituels
 - C. fièvre prolongée angine récidivante
 - D. hématurie
 - E. asthénie pâleur éventuelle dyspnée
- REP: ABD

24. Manifestations en rapport avec un syndrome paranéoplasique du neuroblastome sont:

- A. diarrhée (hyper sécrétion de VIP)
 - B. syndrome opsomyoclonique
 - C. syndrome de Pepper
 - D. mouvements saccadés des yeux, ataxie
 - E. syndrome de marfan
- REP: ABD

25. L'anémie normocytaire

- A. Produit par carence en vitamine B12 ou de l'acide folique
 - B. Anémie héréditaire/acquise
 - C. thalassémie alpha ou bêta
 - D. l'anémie aiguë post hémorragique
 - E. anémie des maladie chroniques
- REP: BDE

E??

26. les causes de carence martiale chez l'enfant sont :

- A. Régime lacté exclusif prolongé
- B. Régime sans lacté prolongé
- C. cardiopathie cyanogène --> OUI
- D. Cardiopathie non cyanogène
- E. maladie coeliaque, autres diarrhées chroniques

REP: AE

27. Traitement curatif de l'endocardite infectieuse est:

- A. durée de traitement endocardite à entérocoques : pénicilline IV 4 semaines
- B. on commence le traitement avec la pénicilline ou l'oxacilline plus la gentamicine, injectable IV
- C. en cas d'allergie à la pénicilline, le traitement se fera avec la gentamicine
- D. en cas d'allergie à la pénicilline, le traitement se fera avec la vancomycine
- E. la durée de traitement d'endocardite à staphylocoques : pénicilline injectable IV 4 semaines plus gentamicine iv 2 semaines

REP: BD

28. Causes non infectieuses de la myocardite sont:

- A. Rarement: champignons, rachitisme, protozoaires et parasites
- B. maladies collagènes
- C. allergique, immuno-allergique
- D. le virus de l'epstein barr, cytomégalovirus, le virus de l'herpès
- E. myocardite primitive FIEDLER

REP: BCE

29. Les troubles à électrocardiogramme dans la péricardite sont les suivants

- A. Hypervoltage du complexe QRS
- B. hypovoltage du complexe QRS
- C. changements caractéristique variable au fil du temps la dépression du segment ST
- D. changements caractéristique variable au fil du temps l'élévation du segment ST
- E. extrasystoles et d'autres arythmies

REP: BD

30. la sténose pulmonaire isolée:

- A. Une malformation cardiaque congénitale cyanogène
- B. Une malformation cardiaque congénitale non cyanogène
- C. Le patient peut être asymptomatique
- D. la dyspnée d'effort et la fatigue se produisent tout le temps
- E. la dyspnée d'effort et la fatigue se produisent uniquement si le débit cardiaque est insuffisant

REP: BCE

--> classée dans MCC non cyanogène mais décrite comme cyanogène

31. La tétralogie de fallot est représentée par l'association de suivantes lésions:

- A. Le défaut septal interatrial péri-membraneux
- B. le défaut septal interventriculaire péri-membraneux
- C. la sténose infundibulaire de l'aorte
- D. la sténose infundibulaire de l'artère pulmonaire
- E. l'hypertrophie ventriculaire droite

REP: BDE

32. *le signe pathognomonique dans la myocardite est:

- A. la taille du coeur normale = pointe arrondie, aorte dilatée et la stase rétrograde du poumon
- B. CA large = HTP, oedème pulmonaire, dilatation des cavités gauches
- C. cardiomégalie et la pléthore pulmonaire
- D. coeur en flash
- E. ombre du coeur est augmenté par l'élargissement de AD et VD associé au pléthore pulmonaire

REP: D

33. dans le RGO, les rejets ou vomissements ont des caractéristiques évocatrices du diagnostic :

- A. tout vomissement bilieux est un signe RGO
- B. Ne sont pas favorisés par l'alimentation liquide
- C. favorisés par l'alimentation liquide
- D. sont constantes
- E. ne sont pas constantes

REP: CE

34. Les régimes thérapeutiques de l'infection par helicobacter pylori de première ligne sont:

- A. La triple thérapie - Amoxicilline (50 mg/kg/jour) + Clarithromycine (15 mg/kg/jour) juste pour les cas sensible à la clarithromycine + IPP, 2 doses/jr
- B. La triple thérapie - IPP + Levofloxacin + Amoxicilline (50 mg/kg/jour) en 2 doses /jours
- C. La quadruple thérapie - Amoxicilline (50 mg/kg/jour) + Métronidazole (30-40 mg/kg/jour) + sels de bismuth 2 doses/jr
- D. La quadruple thérapie - IPP + Amoxicilline (50 mg/kg/jr) 5 jours après IPP + clarithromycine (15 mg/kg/jr) ou Métronidazole (30-40 mg/kg/jr), 5 jours, 2 doses /jour
- E. La thérapie séquentielle - IPP + Amoxicilline (50 mg/kg/jr) 5 jours après IPP + Clarithromycine (15 mg/kg/jour) ou Métronidazole (30-40 mg/kg/jr), 5 jours, 2 doses /jour

REP: AE

35. La classification de la déshydratation aiguë est:

- A. hyponatrémique - déficit en sel est supérieur au déficit en eau : il s'agit d'une déshydratation à prédominance intracellulaire, hyponatrémique, isoosmolaire
 - B. hyponatrémique - déficit en sel est supérieur au déficit en eau : il s'agit d'une déshydratation à prédominance extracellulaire, hyponatrémique, hypo osmolaire
 - C. isonatrémique - déficit en eau et en sel sont proportionnels : la déshydratation est globale, isonatrémique, iso osmolaire
 - D. isonatrémique - déficit en eau et en sel sont proportionnels : la déshydratation est hyponatrémique, hypo osmolaire
 - E. hypernatrémique - le déficit en eau est proportionnellement supérieur au déficit en sel : il s'agit d'une déshydratation à prédominance intracellulaire, hypernatrémique, hyperosmolaire
- REP: BCE

36. La forme classique de la maladie coeliaque est caractérisée par la triade coeliaque:

- A. stéatorrhée
 - B. constipation ou prolapsus rectal isolé
 - C. augmentation du volume abdominale
 - D. formes hypotrophiques qui visent d'abord le poids puis la taille
 - E. la malnutrition auxquelles on ajoute l'apathie et l'irritabilité
- REP : ACE

37. Score Marsh, modifiée par Oberhuber dans la maladie coeliaque met l'accent sur:

- A. stade 0 : architecture de l'intestin n'est pas affecté (maladie coeliaque potentielle ou latente)
 - B. stade 0 : infiltration (infiltrat lymphocytaire dans le chorion)
 - C. stade 2 : infiltration (infiltrat lymphocytaire dans le chorion)
 - D. stade 2 - qui inclut l'atrophie villositaire partielle, subtotal ou total - les sous types IIa, IIb, respectivement IIc
 - E. le stade 2- hyperplasie (des infiltrats lymphoplasmocytaires dans le chorion villositaire associés avec hyperplasie glandulaire)
- REP: AE

38. Les examens sérologiques des maladies inflammatoires chroniques intestinales mettent l'accent sur:

- A. ASCA : positif chez $\frac{3}{4}$ de patients atteint de RCH
 - B. ASCA : positifs chez $\frac{2}{3}$ de patients atteint de MC
 - C. ANCA : positifs chez $\frac{3}{4}$ des patients atteint de RCH
 - D. ANCA : positifs chez $\frac{3}{4}$ des patients atteint de MC
 - E. Coproculture et virologie des selles, recherche de toxines clostridium difficile
- REP: BC

39. les signes suivants peuvent suggérer une leucémie aiguë lymphoblastique:

- A. Pâleur
- B. hypothermie
- C. hématurie
- D. angine récidivante
- E. hyperglycémie

REP: ACD

40. La myocardite s'associe avec:

- A. Bruits cardiaques étouffés, souffle systolique
- B. Wheezing
- C. hypervoltage du complexe QRS
- D. le coeur en flash avec angles obtus par rapport au diaphragme
- E. Silhouette cardiaque allongée

REP: ACDE

41. dans la d-transposition classique de gros vaisseaux :

- A. L'aorte émerge du ventricule gauche
- B. l'artère pulmonaire émerge du ventricule gauche
- C. l'aorte émerge du ventricule droit
- D. il ne faut pas exister un mélange du sang
- E. la cyanose est grave dès la naissance

REP: BCE

42. l'étiologie des vomissements aigus comprend :

- A. Les infection ORL
- B. Hypovitaminose A
- C. Méningite
- D. Infections respiratoires
- E. Syndrome de Down

REP: ACD

43. les antibiotiques recommandés pour les diarrhées aiguës sont :

- A. Shigelle : ampicilline (100 mg/kg/j)
- B. Salmonella : Ceftriaxone (50 mg/kg/j)
- C. Shigella : ibuprofène (20-30 mg/kg/j)
- D. Campylobacter jejuni : Erythromycine (50 mg/kg/j per os)
- E. Salmonelle : Gentamicine 40 mg/kg/j

REP: ABD

44. l'hépatite chronique avec virus B, dans la période inactive, non répliquative :

- A. Ag HBs
- B. Ac anti-HBs
- C. Ag HBe
- D. ADN viral PCR
- E. Ac anti-Hbe

REP: AE

B??

45. hépatite C chronique a les suivantes caractéristiques sérologiques positives :

- A. Ac IgM anti-VHC
- B. Ac IgG anti-VHC
- C. IgM-HBc
- D. IgG- anti HBc
- E. ARN viral par PCR

REP: BE

46. les manifestations cliniques dans le diabète associé à la fibrose kystique (DAFK) :

- A. Début insidieux, elle débute rarement en une acidose
- B. La détérioration de la fonction pulmonaire
- C. La polyurie et la polydipsie sont moins fréquentes
- D. Les complications de diabètes spécifiques (micro et macro-angiopathie) sont fréquentes
- E. augmentation de l'appétit, gain de poids, la fatigue

REP: ABC

47. *les complications métaboliques de l'obésité idiopathique sont à l'exception :

- A. hépato stéatose
- B. HTA
- C. Sdr. ovaires polykystiques
- D. DS type II
- E. syndrome métabolique

REP : B

48. Etiologie des pneumonies par groupe d'âge énumère :

- A. nouveau née : streptocoque bêta groupe B, VRS
- B. Ecolier : Streptocoque pneumoniae, v. gripal
- C. nourrisson : chlamydia trachomatis, Strepto bêta hémolytique
- D. adolescent : pneumocystis
- E. petits enfants : virus rougeole

REP: ABCE

49. les facteurs prédisposant pour l'apparition des pneumonies sont :

- A. prématurité
- B. reflux vésico urétéral
- C. déficit immunitaire congénital ou acquis - traitements immunosuppresseurs
- D. obésité
- E. hypergammaglobulinémie

REP: AC

50. la physiopathologie de l'asthme bronchique implique :

- A. prédominante de la réponse de type Th2
- B. formation de cytokines anti inflammatoires --> OUI
- C. activation des cellules B
- D. pour former des anticorps de type IgG
- E. dégranulation des éosinophiles et neutrophiles

REP: AC

51. les caractéristiques de l'obésité idiopathique sont :

- A. âge osseux normale ou avancé pour l'âge chronologique
- B. ATCD familiaux d'obésité secondaire
- C. symptômes évocateurs de la maladie qui peuvent être associés avec l'obésité
- D. intelligence normale
- E. haute stature généralement au dessus du 50e percentile

REP: ADE